

التميّز التشغيلي · من الدراسات العلمية

حين لا يجد المريض سريرًا في المستشفى، يبقى في قسم الطوارئ، وللانتظار هناك ثمن.

دراستان حديثتان من إنجلترا وكوريا الجنوبية شملتا ملايين المرضى.

← اسحب للمتابعة

كيف يتحول امتلاء الأسرّة إلى انتظار؟

لا تصل الحالات الطارئة بانتظام. وحين تمتلئ أسرّة الأقسام، لا يجد المريض الذي قرر الأطباء إدخاله مكانًا ينتقل إليه، فيبقى في قسم الطوارئ، ويزدحم القسم بمن ينتظرون.

ونقصد بالإشغال نسبة الأسرّة المشغولة من مجموع الأسرّة المتاحة.

الدراسة الأولى: إنجلترا

بعد الساعة الخامسة، صار لكل ساعة انتظار ثمن

حلّل باحثون بيانات 5.2 مليون مريض أُدخلوا المستشفى من أقسام الطوارئ الرئيسية في إنجلترا بين عامي 2016 و2018، ونُشرت الدراسة عام 2022.

5

ساعات من الوصول، وبعدها أخذت الوفيات خلال ثلاثين يومًا تزيد كلما طال الانتظار، حتى 12 ساعة.

8%

هي أكبر زيادة في نسبة الوفيات، وظهرت لدى من انتظروا أكثر من 6 إلى 8 ساعات.

Jones et al., Emerg Med J, 2022

TAMAYUZ 10X

ما تعنيه الأرقام

وفاة إضافية لكل 82 مريضًا

1 من كل 82

قدّرت الدراسة أنه مقابل كل 82 مريضًا يتأخر نقلهم إلى سرير في المستشفى أكثر من 6 إلى 8 ساعات من وصولهم، تحدث وفاة إضافية واحدة.

الدراسة الثانية: كوريا الجنوبية

100%

حين امتلأت أسرّة الطوارئ، ارتفعت احتمالات الوفاة

حلّل باحثون نحو 26 مليون زيارة لأقسام الطوارئ بين عامي 2018 و2022. وحين بلغ إشغال أسرّة الطوارئ 100% أو أكثر، ارتفعت احتمالات الوفاة داخل المستشفى بنحو 12% في الأقسام الأعلى مستوى، و21% في الأقسام الأدنى مستوى.

والفكرة لا تخصّ المستشفيات وحدها

كل نظام يستقبل طلبًا غير منتظم، من مركز الاتصال إلى خط الإنتاج إلى فريق يعالج المعاملات، يتصرف بطريقة مشابهة: كلما اقترب من طاقته الكاملة، طالت الطوابير بسرعة تفوق الزيادة في العمل نفسه.

هذا استنتاج من نظرية الطوابير (Queueing theory)، وهي فرع من الرياضيات التطبيقية يدرس الانتظار، وليس نتيجة من الدراستين.

الهامش الفارغ ليس هدرًا، بل جزء من تصميم النظام

1

قِس الإشغال في أوقات الذروة، لا متوسطه السنوي وحده، لأن المتوسط يُخفي الأيام التي يختنق فيها النظام.

2

خطّط للطاقة بحيث تستوعب تذبذب الطلب، لا الطلب المتوسط فقط.

3

تابع الوقت الذي ينتظره المريض حتى يصل إلى سريره، فهو يكشف ازدحام المستشفى كله، لا ازدحام الطوارئ وحدها.

> **إذا كان فريقك مشغولًا طوال الوقت، فأين سيذهب العمل الطارئ غدًا؟**

حدود هذه الأدلة

الدراستان رصديتان تثبتان ارتباطًا لا سببية، مع أن الباحثين عدّلوا النتائج بحسب العمر والأمراض المصاحبة وعوامل أخرى.

لم تجد دراسة في ستوكهولم ارتباطًا بين إشغال أسرّة المستشفى والوفيات، فالأثر قد يختلف من نظام صحي إلى آخر.

أُجريت الدراستان في إنجلترا وكوريا الجنوبية، ولم تشملا مستشفيات عربية.

تنويه تحريري: الآراء والتحليلات الواردة في هذا المقال تمثل رأي الكاتب وتحليله المهني استنادًا إلى المصادر المشار إليها، ولا تمثل بالضرورة المواقف الرسمية للجهات المذكورة. وللاطلاع على المعلومات والمراجع الأصلية والكاملة والأحدث، يُرجى الرجوع مباشرة إلى المصادر الأصلية والوثائق الرسمية الواردة في قائمة المراجع.

[1] Jones, S., Moulton, C., Swift, S., et al. (2022). Association between delays to patient admission from the emergency department and all-cause 30-day mortality. *Emergency Medicine Journal*, 39(3), 168–173.

[2] Kim, M., Lee, J. H., Choi, M., et al. (2026). Association between emergency department crowding and mortality: a nationwide analysis stratified by emergency department levels. *BMC Emergency Medicine*, 26(1), 153.

[3] af Ugglas, B., et al. (2020). Association between hospital bed occupancy and outcomes in emergency care: a cohort study in Stockholm Region, Sweden, 2012 to 2016. *Annals of Emergency Medicine*.